

CAPÍTULO 10.24

Infección de Piel y Partes Blandas

PERFIL EUNACOM 1.05.1.024

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Infecciones de Piel y Partes Blandas

Agentes más comunes: *Staphylococcus aureus* (SA) y *Streptococcus pyogenes* (SP Grupo A). **Diagnóstico:** Clínico en todos los casos. **Principio:** Lo que cubre SA cubre también SP (no al revés). Ante la duda → cubrir SA.

Tabla Comparativa

TABLA 10.24.1: ENFERMEDAD VS AGENTE			
ENFERMEDAD	AGENTE	CLÍNICA DIFERENCIADORA	TRATAMIENTO
Erisipela	Solo SP	Placa eritematosa, bordes muy nítidos , linfangitis, fiebre alta	Penicilina G EV
Celulitis	SA y SP	Placa eritematosa, bordes difusos (difíciles de definir)	Cloxacilina o Cefazolina EV
Fasceítis Necrotizante	SP (o polimicrobiana en diabético/Gangrena de Fournier)	Placa muy dolorosa , violácea-negra con necrosis, bulas hemorrágicas. Urgencia quirúrgica.	Penicilina G EV + Clindamicina + Desbridamiento quirúrgico
Shock Tóxico	SA o SP productores de exotoxina	Hipotensión refractaria + fiebre + eritrodermia (SA especialmente)	ATB EV + Clindamicina + Suero + Noradrenalina
Síndrome de Piel Escaldada	SA (toxina exfoliativa)	Eritema periorcular → bulas → despegamiento epidérmico. Signo de Nikolsky (+)	Cloxacilina EV + Clindamicina + hidratación
Impétigo	SA y SP	Costras mielicéricas alrededor de boca/nariz ("boca de payaso")	Oral: Cloxacilina/Cefalexina, o Tópico: Mupirocina
Impétigo Bulloso	SA (toxina exfoliativa localizada)	Igual al impétigo + bulas flácidas	Mismo que impétigo

Infecciones del Folículo Piloso

TABLA 10.24.2: ENFERMEDAD VS AGENTE			
ENFERMEDAD	AGENTE	CLÍNICA	TRATAMIENTO
Foliculitis	SA (o Pseudomonas en sauna/piscina)	Pústulas en folículo piloso. Zona de barba o genital.	Cloxacilina VO (o Ciprofloxacino si Pseudomonas)
Furúnculo	SA	Como foliculitis pero más grande y profundo	Nada / Cloxacilina VO / drenaje
Ántrax estafilocócico	SA	Varios furúnculos agrupados en masa inflamatoria	Cloxacilina o Cefazolina EV + Drenaje quirúrgico

Resumen de ATB por gravedad

TABLA 10.24.3: GRAVEDAD VS FÁRMACO BASE	
GRAVEDAD	FÁRMACO BASE
Leve (VO)	Cloxacilina / Cefalexina
Grave (EV)	Cloxacilina / Cefazolina
Alérgico	Clindamicina
SAMR	Vancomicina EV

| Cuadro grave (fasceítis, shock, piel escaldada) | Agregar **Clindamicina EV** (↓ producción de toxinas) |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Paciente presenta placa eritematosa en pierna derecha con bordes difíciles de delimitar, fiebre de 38°C y dolor local moderado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el tratamiento?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Infección de Piel y Partes Blandas. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

EUNACOM CRITERIOS

Fasceítis → 3 claves: dolor intenso → sospechar / RMN confirmar → desbridamiento quirúrgico de urgencia.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Grampositivos: *S. pyogenes* (penicilina, 0% resistencia) y *S. aureus* (cloxacilina/cefazolina; MRSA = vancomicina). Todo lo que cubre SA cubre SP.
- Erisipela (SP): bordes NÍTIDOS, compromiso linfático. Celulitis (SA): bordes DIFUSOS. Ante duda: cubrir SA.
- Fascitis necrotizante (SP): placa violácea/necrótica, dolor intenso, bulas hemorrágicas. Penicilina + clindamicina EV + debridación quirúrgica URGENTE.
- Shock tóxico (SA o SP, exotoxina 1): hipotensión refractaria. Eritrodermia = orienta a SP. Tratamiento: ATB + clindamicina + noradrenalina.
- Piel escaldada (SA, toxina exfoliativa): desprendimiento epidérmico, signo de Nikolsky (+). Cloxacilina + clindamicina EV + hidratación como gran quemado.
- Impétigo: costras melicéricas periorales (boca de payaso). Tratamiento tópico (mupirocina) u oral. Impétigo buloso (SA): agrega bulas flácidas.
- Clindamicina se agrega en cuadros GRAVES (fascitis, shock tóxico, piel escaldada) para disminuir producción de toxinas.
- Foliculitis del sauna: *Pseudomonas aeruginosa*, tratamiento con ciprofloxacino. Ántrax estafilocócico: furúnculos confluentes, cloxacilina EV + drenaje.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (INFECCIÓN DE PIEL Y PARTES BLANDAS)**PREGUNTA 1**

Paciente presenta placa eritematosa en pierna derecha con bordes difíciles de delimitar, fiebre de 38°C y dolor local moderado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el tratamiento?

- A)** Erisipela; penicilina G endovenosa
- B)** Celulitis; cloxacilina o cefazolina endovenosa
- C)** Fascitis necrotizante; penicilina más clindamicina y cirugía
- D)** Impétigo; mupirocina tópica
- E)** Celulitis; penicilina oral

PREGUNTA 2

Lactante de 6 meses presenta eritema periocular que progresa a bulas en pliegues que se rompen con desprendimiento epidérmico al presionar con el dedo. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- A)** Penicilina G endovenosa
- B)** Cloxacilina endovenosa más clindamicina endovenosa más hidratación
- C)** Corticoides sistémicos
- D)** Vancomicina endovenosa
- E)** Mupirocina tópica solamente

PREGUNTA 3

Paciente diabético con herida infectada en pie presenta placa violácea que avanza rápidamente con zonas necróticas y bulas hemorrágicas. ¿Cuál es la conducta más urgente?

- A)** Antibióticos endovenosos y reevaluar en 24 horas
- B)** Solicitar RMN para confirmar fascitis antes de operar
- C)** Antibióticos endovenosos (penicilina + clindamicina) más debridación quirúrgica urgente
- D)** Cloxacilina endovenosa y curación avanzada de heridas
- E)** Vancomicina endovenosa por sospecha de MRSA en diabético

RESUMEN: INFECCIÓN DE PIEL Y PARTES BLANDAS

Esta clase aborda las infecciones de piel y partes blandas, causadas por bacterias grampositivas (*S. aureus* y *S. pyogenes*). El diagnóstico es clínico en todas. El tratamiento del *S. pyogenes* leve es con amoxicilina/ampicilina oral, grave con penicilina G EV; alérgicos con azitromicina o clindamicina (0% resistencia a penicilina). Para *S. aureus* leve: cloxacilina/flucloxacilina/cefadroxilo oral, grave: cloxacilina/cefazolina EV; alérgicos solo clindamicina; resistente (MRSA): vancomicina. En cuadros graves se agrega clindamicina EV (disminuye producción de toxinas). La erisipela (*S. pyogenes*) produce placa eritematosa con bordes NÍTIDOS, compromiso linfático, fiebre alta; tratamiento con penicilina EV. La celulitis (*S. aureus*) produce placa con bordes DIFUSOS; tratamiento con cloxacilina/cefazolina. La fascitis necrotizante (*S. pyogenes*) produce placa dolorosa, violácea, con necrosis y bulas hemorrágicas; tratamiento con penicilina + clindamicina EV más debridación quirúrgica urgente. El shock tóxico (*S. aureus* o *S. pyogenes* con exotoxina 1/superantígeno) produce hipotensión refractaria; si eritrodermia orienta a *S. pyogenes*. El síndrome de piel escaldada (*S. aureus*, toxina exfoliativa) produce desprendimiento epidérmico con signo de Nikolsky; tratamiento con cloxacilina + clindamicina EV. El impétigo (ambos) produce costras melicéricas periorales; tratamiento tópico (mupirocina) u oral. El impétigo buloso (*S. aureus* con toxina exfoliativa) agrega bulas flácidas. La foliculitis (*S. aureus*): pústulas en folículos pilosos, si del sauna es por *Pseudomonas* (ciprofloxacino). El furúnculo: foliculitis grande, manejo conservador o drenaje. El ántrax estafilocócico: masa de furúnculos confluentes, cloxacilina/cefazolina EV + drenaje quirúrgico.